FRONT

EN

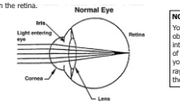
PATIENT INFORMATION LEAFLET

Device Type: Intraocular Lens (Phakic)

Introduction
This patient information leaflet is designed to help you decide whether you want to have an Implantable Phakic Contact Lens (IPCL V2.0) placed in one or both eyes to correct your nearsightedness (myopia) or farsightedness (hyperopia). It is important to understand the benefits and possible risks before making your decision. Please read this leaflet carefully and discuss any questions with a doctor trained in IPCL V2.0 surgery.

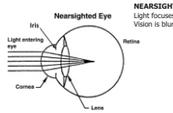
What Is Nearsightedness and farsightedness?

NORMAL EYE
Light focuses on the retina.
Vision is clear.



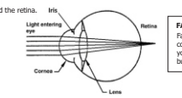
NORMAL EYE:
Your eye works like a camera. You see objects because your eye focuses light into images. Both the clear front layer of your eye, called the cornea, and your natural crystalline lens focuses rays of light onto the back surface of the eye, called the retina.

NEARSIGHTED EYE
Light focuses in front of the retina.
Vision is blurry.



NEARSIGHTED EYE:
Nearsightedness is a focusing error that causes blurrier vision at distance than at near. Light from an object in the distance focuses in front of the back surface of your eye (retina) responsible for capturing images, rather than directly on the retina.

FARSIGHTED EYE
Light Focuses behind the retina.
Vision is blurry

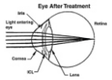


FARSIGHTED EYE:
Farsightedness (hyperopia) is a common vision condition in which you can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry.

Glasses and contact lenses can help your eye focus light properly on the retina. The IPCL V2.0 can also help your eye focus light properly on the retina.

How Does IPCL V2.0 Correct Nearsightedness and farsightedness?

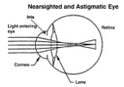
CORRECTION OF VISION AFTER IPCL V2.0 SURGERY



A diopter (D) is a unit used to measure how well your eye can focus. It shows the level of nearsightedness, farsightedness, or astigmatism you have. IPCL V2.0 surgery can treat nearsightedness from -0.5 D to -15.0 D and farsightedness from +0.5 D to +15.0 D. If your vision falls within these ranges, this surgery may help you see clearly without glasses or contact lenses.

The IPCL V2.0 monofocal lens does not correct astigmatism. Astigmatism is a common vision problem that causes blurred or uneven vision. It happens when the front surface of the eye (cornea) is not evenly shaped. Because of this, light does not focus properly inside the eye, and some parts of what you see may look clearer than others.

NEARSIGHTED and ASTIGMATIC EYE



IPCL V2.0 Toric / IPCL V2.0 Presbyopic Toric can correct any astigmatism you have upto +1.0 D to +10D. You are requested to consult your doctors to choose appropriate suitable options for your eye.

Choosing the best lens for your vision
There are different types of lenses available. Your eye doctor will help you choose the one that is best for you. Other treatment options include glasses with thick lenses or contact lenses instead of a permanent lens implant. Talk to your eye doctor about the benefits and possible risks of each option

Other Treatments to Correct Nearsightedness and Farsightedness ?
Other treatments to correct nearsightedness and farsightedness include eyeglasses, contact lenses, and refractive surgical procedures. Surgical options include Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK), refractive lens exchange (RLE), and phakic intraocular lens implantation (e.g., IPCL V2.0). Reviewing these procedures may not meet the visual requirements for certain professions, such as military service.

These procedures either reshape the cornea or place a lens inside the eye. PRK and LASIK use a laser to change the shape of the cornea so the eye can focus better. In LASIK, a thin flap of the cornea is lifted, the laser reshapes the tissue underneath, and the flap is put back in place to heal. Phakic intraocular lens implantation, like IPCL V2.0, adds an artificial lens inside the eye without removing your natural lens.

Benefit And Risks of the IPCL V2.0
IPCL V2.0 surgery can safely correct nearsightedness between –0.5D to –15D and farsightedness between +0.5D to +15D. If your eyeglass prescription is in these ranges, the IPCL V2.0 may make your distance vision without eyeglasses or contact lens correction better.
Implanting IPCL V2.0 requires eye surgery, which carries potential risks. Please read this leaflet carefully and talk to your doctor about the possible risks.

■ **Few of the risks are as below**

- Additional surgery

Sometimes, a second surgery may be needed to remove, replace, or adjust the IPCL V2.0. It may need to be removed during cataract surgery. Additional surgery might also be needed to reduce eye pressure.

- Cataract formation

After Phakic IOL surgery, there is an increased risk that the natural lens of your eye may become cloudy, leading to cataracts that could require surgery. The longer the IPCL V2.0 stays in the eye, the higher this risk. Regular eye exams are important to check for cataracts. Older patients and those with stronger nearsightedness or farsightedness may have a higher risk. The long-term risk beyond 7 years is not known. If cataract surgery is needed, the IPCL V2.0 and the cloudy lens are removed, and a new lens is implanted, just like routine cataract surgery.

- Loss of Best Corrected Vision (BCVA)

The most common reason was clouding of the natural lens (cataract). Vision may get better in these eyes after cataract surgery.

- Raised pressure inside the eye and damage to the optical nerve caused by increased pressure in eye (Glaucoma)

Normal eye pressure (intraocular pressure or IOP) can vary but is often considered to be from 10-21 millimeters of mercury (mmHg). An IOP higher than normal is called ocular hypertension and if left untreated, can cause damage to the optic nerve (glaucoma) and cause permanent vision loss.

- **Endothelial Cell Loss**

The corneal (the clear front part of your eye) has a thin layer of special cells called endothelial cells. These cells keep the cornea clear by removing extra fluid. Normally, the number of these cells slowly decreases with age. Eye surgery, including IPCL V2.0, can cause additional loss of these cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for IPCL V2.0. After the surgery, some ongoing loss of these cells may occur over time. If too many cells are lost, fluid can build up in the cornea (called corneal edema), which may require a cornea transplant.

■ **Other Complications**

Other risks associated with IPCL V2.0 surgery may include:

- movement of the colored portion of the eye (iris) through a surgical wound to a position outside the eye (iris prolapse),
- bleeding in the area on the retina responsible for reading vision (macular hemorrhage),
- bleeding under the retina (subretinal hemorrhage),
- increase in focusing error (astigmatism),
- lifting or pulling of the retina from its natural position (retinal detachment),
- unequal pupil size (anisocoria).

Adverse reactions and complications due to, or following surgery and implication of any implantable Phakic Contact Lens may include, but are not limited to:

- Increased astigmatism
- Refractive error
- Intraocular infection
- Vitreous loss
- Vaulting issue
- Anterior subcapsular cataract
- Severe intraocular inflammation
- Glaucoma
- Secondary glaucoma
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphema
- Hypopyon
- Under/over correction
- Non-reactive pupil
- Endophthalmitis
- TASS
- Retinal Detachment
- Iritis
- Cystoid macular edema
- Macular edema
- Corneal decompensation
- Corneal edema
- Pupillary block
- Iris Capture
- IOP > 5mmHg over baseline and IOP > 25 mmHg
- Significant glare and/or halos around lights
- Decentration/rotation of the IPCL V2.0
- Corneal endothelial cell loss
- Lens dislocation/rotation of the IPCL V2.0
- Loss of best spectacle corrected visual acuity
- Secondary surgical intervention to remove/replace the IPCL V2.0

FR

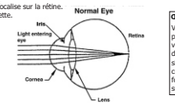
NOTICE D'INFORMATION DESTINÉE AU PATIENT

Type de dispositif : Lentille intraoculaire (phake)

Introduction
Cette notice d'information destinée au patient a été conçue pour vous aider à décider si vous souhaitez qu'une lentille de contact phake implantable (IPCL V2.0) soit implantée dans un ou dans les deux yeux afin de corriger votre myopie ou votre hypermétropie. Il est important de comprendre les avantages et les risques potentiels avant de prendre votre décision. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter de toute question avec un médecin formé à la chirurgie de l'IPCL V2.0.

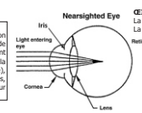
Qu'est-ce que la myopie et l'hypermétropie ?

ŒIL NORMAL
La lumière se focalise sur la rétine.
La vision est nette.



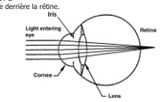
ŒIL NORMAL :
Votre œil fonctionne comme un appareil photo. Vous voyez les objets parce que votre œil focalise la lumière pour former des images. La couche transparente située à l'avant de votre œil, appelée cornée, ainsi que votre cristallin naturel, focalisent les rayons lumineux sur la surface arrière de l'œil appelée rétine.

ŒIL MYOPE :
La myopie est un défaut de focalisation qui provoque une vision plus floue de loin que de près. La lumière provenant d'un objet éloigné se focalise devant la surface arrière de votre œil (la rétine), responsable de la capture des images, au lieu de se focaliser directement sur la rétine.



ŒIL MYOPE
La lumière se focalise devant la rétine.
La vision est floue.

ŒIL HYPERMÉTROPE
La lumière se focalise derrière la rétine.
La vision est floue.

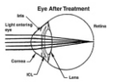


ŒIL HYPERMÉTROPE :
L'hypermétropie est un trouble visuel fréquent dans lequel vous pouvez voir clairement les objets éloignés, tandis que les objets proches peuvent apparaître flous.

Les lunettes et les lentilles de contact peuvent aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine. L'IPCL V2.0 peut également aider votre œil à focaliser correctement la lumière sur la rétine.

Comment l'IPCL V2.0 corrige-t-elle la myopie et l'hypermétropie ?

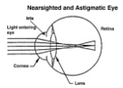
CORRECTION DE LA VISION APRÈS UNE CHIRURGIE IPCL V2.0



La dioptrie (D) est une unité utilisée pour mesurer la capacité de votre œil à effectuer correctement la mise au point. Elle indique le degré de myopie, d'hypermétropie ou d'astigmatisme dont vous êtes atteint. La chirurgie IPCL V2.0 peut traiter la myopie de -0,5 D à -15,0 D et l'hypermétropie de +0,5 D à +15,0 D. Si votre défaut visuel se situe dans ces plages, cette intervention peut vous aider à voir clairement sans lunettes ni lentilles de contact.

La lentille monofocale IPCL V2.0 ne corrige pas l'astigmatisme. L'astigmatisme est un trouble visuel fréquent qui provoque une vision floue ou irrégulière. Il survient lorsque la surface antérieure de l'œil (la cornée) n'a pas une forme parfaitement régulière. En conséquence, la lumière ne se focalise pas correctement à l'intérieur de l'œil et certaines parties de ce que vous voyez peuvent paraître plus nettes que d'autres.

ŒIL MYOPE ET ASTIGMATE



L'IPCL V2.0 Torique / IPCL V2.0 Presbyopique Torique peut corriger un astigmatisme compris entre +1,0 D et +10 D. Il vous est demandé de consulter votre médecin afin de choisir l'option la plus appropriée à votre œil.

Choisir la meilleure lentille pour votre vision
Il existe différents types de lentilles disponibles. Votre ophtalmologiste vous aidera à choisir celle qui vous convient le mieux. D'autres options de traitement comprennent les lunettes à verres épais ou les lentilles de contact au lieu d'un implant permanent. Discutez avec votre ophtalmologiste des avantages et des risques potentiels de chaque option.

Autres traitements pour corriger la myopie et l'hypermétropie?
Les autres traitements destinés à corriger la myopie et l'hypermétropie comprennent les lunettes, les lentilles de contact et les procédures chirurgicales réfractives.Les options chirurgicales comprennent la kératectomie photoréfractive (PRK), le laser in situ kératomileusis assisté par laser (LASIK), l'échange de cristallin réfractif (RLE) et l'implantation de lentilles intraoculaires phakes (par exemple l'IPCL V2.0). Toutefois, ces procédures peuvent ne pas répondre aux exigences visuelles de certaines professions, telles que le service militaire.

Ces procédures consistent soit à remodeler la cornée, soit à placer une lentille à l'intérieur de l'œil. La PRK et le LASIK utilisent un laser pour modifier la forme de la cornée afin d'améliorer la capacité de l'œil à effectuer la mise au point. Dans le LASIK, un fin volet cornéen est soulevé, le laser remodelé le tissu sous-jacent, puis le volet est repositionné afin de cicatriser. L'implantation d'une lentille intraoculaire phake, telle que l'IPCL V2.0, ajoute une lentille artificielle à l'intérieur de l'œil sans retirer votre cristallin naturel.

Avantages et risques de l'IPCL V2.0
La chirurgie IPCL V2.0 peut corriger en toute sécurité la myopie comprise entre –0,5 D et –15 D ainsi que l'hypermétropie comprise entre +0,5 D et +15 D. Si votre correction optique se situe dans ces plages, l'IPCL V2.0 peut améliorer votre vision de loin sans lunettes ni lentilles de contact.
L'implantation de l'IPCL V2.0 nécessite une intervention chirurgicale oculaire, qui comporte des risques potentiels. Veuillez lire attentivement cette notice et discuter avec votre médecin des risques éventuels.

■ **Quelques-uns de ces risques sont décrits ci-dessous.**

- Intervention chirurgicale supplémentaire

Dans certains cas, une seconde intervention peut être nécessaire pour retirer, remplacer ou ajuster l'IPCL V2.0. Elle peut également devoir être retirée lors d'une chirurgie de la cataracte. Une intervention supplémentaire peut aussi être nécessaire afin de réduire la pression intraoculaire.

- Formation d'une cataracte

Après une chirurgie avec une lentille intraoculaire phake, le risque que le cristallin naturel de votre œil devienne opaque est accru, ce qui peut entraîner une cataracte nécessitant une intervention chirurgicale. Plus l'IPCL V2.0 reste longtemps dans l'œil, plus ce risque augmente. Des examens oculaires réguliers sont importants afin de surveiller l'apparition éventuelle d'une cataracte. Les patients plus âgés ainsi que ceux présentant une myopie ou une hypermétropie plus importante peuvent présenter un risque plus élevé. Le risque à long terme au-delà de 7 ans n'est pas connu. Si une chirurgie de la cataracte devient nécessaire, l'IPCL V2.0 ainsi que le cristallin opacifié sont retirés et une nouvelle lentille est implantée, comme lors d'une chirurgie standard de la cataracte.

- Perte de la meilleure acuité visuelle corrigée (BCVA)

La cause la plus fréquente était l'opacification du cristallin naturel (cataracte). La vision peut s'améliorer dans ces cas après une chirurgie de la cataracte.

- Augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et atteinte du nerf optique causée par une pression intraoculaire élevée (glaucome)

La pression intraoculaire à l'intérieur de l'œil (pression intraoculaire ou PIO) peut varier, mais elle est généralement comprise entre 10 et 21 millimètres de mercure (mmHg). Une pression intraoculaire supérieure à la normale est appelée hypertension oculaire et, si elle n'est pas traitée, peut provoquer une atteinte du nerf optique (glaucome) et entraîner une perte permanente de la vision.

■ **Perte de cellules endothéliales**
La cornée (la partie transparente située à l'avant de l'œil) possède une fine couche de cellules spécialisées appelées cellules endothéliales. Ces cellules maintiennent la transparence de la cornée en éliminant l'excès de liquide. Normalement, le nombre de ces cellules diminue lentement avec l'âge. Une chirurgie oculaire, y compris l'implantation de l'IPCL V2.0, peut entraîner une perte supplémentaire de ces cellules. Si un trop grand nombre de cellules est perdu, la cornée peut devenir trouble et affecter votre vision. Avant l'intervention, votre médecin examinera vos yeux afin de déterminer si vous êtes un candidat approprié pour l'IPCL V2.0. Après l'intervention, une perte progressive de ces cellules peut continuer à se produire au fil du temps. Si un nombre trop important de cellules est perdu, du liquide peut s'accumuler dans la cornée (œdème cornéen), ce qui peut nécessiter une transplantation cornéenne.

■ **Autres complications**
Les autres risques associés à la chirurgie IPCL V2.0 peuvent inclure :

- déplacement de la partie colorée de l'œil (iris) à travers une plaie chirurgicale vers une position située à l'extérieur de l'œil (prolapsus de l'iris) ;
- saignement dans la zone de la rétine responsable de la vision de lecture (hémorragie maculaire) ;
- saignement sous la rétine (hémorragie sous-rétinienne) ;
- augmentation du défaut de réfraction (astigmatisme) ;
- soulèvement ou décollement de la rétine de sa position naturelle (décollement de la rétine) ;
- différence de taille entre les pupilles (anisocorie).

Les effets indésirables et complications liés à la chirurgie ou survenant après celle-ci, ainsi qu'à l'implantation d'une lentille de contact phake implantable, peuvent inclure notamment, sans s'y limiter :

- Augmentation de l'astigmatisme
- Erreur de réfraction
- Infection intraoculaire
- Perte de vitré
- Problème de voûte (vaulting)
- Cataracte sous-capsulaire antérieure
- Inflammation intraoculaire sévère
- Glaucome
- Glaucome secondaire
- Uvéite
- Vitrite
- Hyphéma
- Hypopyon
- Sous-correction/surcorrection
- Pupille non réactive
- Endophtalmie
- Syndrome TASS (syndrome toxique du segment antérieur)
- Décollement de la rétine
- Iritis
- Œdème maculaire cystoïde
- Œdème maculaire

DE

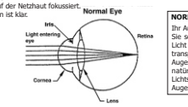
PATIENTENINFORMATIONSBLATT

Produkttyp: Intraokularlinse (phak)

Einleitung
Dieses Patienteninformationsblatt soll Ihnen dabei helfen zu entscheiden, ob bei Ihnen eine implantierbare phake Kontaktlinse (IPCL V2.0) in einem oder beiden Augen eingesetzt werden soll, um Ihre Kurzsichtigkeit (Myopie) oder Weitsichtigkeit (Hyperopie) zu korrigieren. Es ist wichtig, die Vorteile und möglichen Risiken zu verstehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig durch und besprechen Sie alle Fragen mit einem Arzt, der in der IPCL V2.0-Chirurgie geschult ist.

Was sind Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

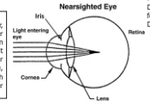
NORMALES AUGE
Das Licht wird auf der Netzhaut fokussiert.
Das Sehvermögen ist klar.



NORMALES AUGE:
Ihr Auge funktioniert wie eine Kamera. Sie sehen Objekte, weil Ihr Auge das Licht zu Bildern fokussiert. Sowohl die transparente vordere Schicht Ihres Auges, die Hornhaut, als auch Ihre natürliche Augenlinse bündeln die Lichtstrahlen auf die Rückseite des Auges, die sogenannte Netzhaut.

KURZSICHTIGES AUGE:
Kurzsichtigkeit ist ein Brechungsfehler, der dazu führt, dass das Sehen in der Ferne unschärfer ist als das Sehen in der Nähe. Das Licht eines weit entfernten Objekts wird vor der Rückseite Ihres Auges (der Netzhaut), die für die Bildaufnahme verantwortlich ist, fokussiert, anstatt direkt auf der Netzhaut.

KURZSICHTIGES AUGE
Das Licht wird vor der Netzhaut fokussiert.
Das Sehvermögen ist unscharf.



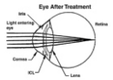
WEITSICHTIGES AUGE
Das Licht wird hinter der Netzhaut fokussiert.
Das Sehvermögen ist unscharf.

WEITSICHTIGES AUGE:
Weitsichtigkeit (Hyperopie) ist eine häufige Sehschwäche, bei der entfernte Objekte klar gesehen werden können, während nahe Objekte unscharf erscheinen können.

Brillen und Kontaktlinsen können Ihrem Auge helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren. Auch die IPCL V2.0 kann Ihrem Auge helfen, das Licht korrekt auf die Netzhaut zu fokussieren.

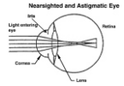
Wie korrigiert die IPCL V2.0 Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit?

SEHKORREKTUR NACH EINER IPCL V2.0-OPERATION



Eine Dioptrie (D) ist eine Maßeinheit zur Bestimmung der Fokussierungsfähigkeit Ihres Auges. Sie zeigt den Grad Ihrer Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Ihres Astigmatismus an. Die IPCL V2.0-Operation kann Kurzsichtigkeit von -0,5 D bis -15,0 D und Weitsichtigkeit von +0,5 D bis +15,0 D behandeln. Wenn Ihre Fehlsichtigkeit innerhalb dieser Bereiche liegt, kann Ihnen diese Operation helfen, ohne Brille oder Kontaktlinsen klar zu sehen.
Die monofokale IPCL V2.0 korrigiert keinen Astigmatismus. Astigmatismus ist eine häufige Sehstörung, die verschwommenes oder ungleichmäßiges Sehen verursacht. Er entsteht, wenn die Vorderfläche des Auges (Hornhaut) nicht gleichmäßig geformt ist. Dadurch wird das Licht im Auge nicht korrekt fokussiert, und einige Bereiche des Sichtfeldes können schärfer erscheinen als andere.

KURZSICHTIGES UND ASTIGMATISCHES AUGE



Die IPCL V2.0 Toric / IPCL V2.0 Presbyopic Toric kann Astigmatismus von +1,0 D bis +10 D korrigieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um die für Ihr Auge am besten geeignete Option auszuwählen.

Die beste Linse für Ihr Sehvermögen auswählen
Es stehen verschiedene Linsentypen zur Verfügung. Ihr Augenarzt wird Ihnen helfen, die für Sie am besten geeignete Linse auszuwählen. Weitere Behandlungsmöglichkeiten umfassen Brillen mit dicken Gläsern oder Kontaktlinsen anstelle eines permanenten Linsenimplantats. Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt über die Vorteile und möglichen Risiken jeder Option.

Andere Behandlungsmöglichkeiten zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit?
Zu den anderen Behandlungsmöglichkeiten zur Korrektur von Kurz- und Weitsichtigkeit gehören Brillen, Kontaktlinsen und refraktive chirurgische Verfahren. Zu den chirurgischen Optionen zählen die photorefraktive Keratektomie (PRK), die laserassistierte In-situ-Keratomileusis (LASIK), der refraktive Linsenaustausch (RLE) sowie die Implantation einer phaken Intraokularlinse (z. B. IPCL V2.0). Tuttavia, queste procedure potrebbero non soddisfare i requisiti visivi richiesti per alcune professioni, come il servizio militare.

Diese Verfahren verändern entweder die Form der Hornhaut oder platzieren eine Linse im Inneren des Auges. PRK und LASIK verwenden einen Laser, um die Form der Hornhaut zu verändern und dadurch die Fokussierungsfähigkeit des Auges zu verbessern. Bei LASIK wird ein dünner Hornhautlappen angehoben, das darunterliegende Gewebe mit dem Laser geformt und der Hornhautlappen anschließend wieder zurückgelegt, damit er verheilen kann. Die Implantation einer phaken Intraokularlinse, wie der IPCL V2.0, fügt dem Auge eine künstliche Linse hinzu, ohne die natürliche Linse zu entfernen.

Vorteile und Risiken der IPCL V2.0
Die IPCL V2.0-Operation kann Kurzsichtigkeit zwischen –0,5 D und –15 D sowie Weitsichtigkeit zwischen +0,5 D und +15 D sicher korrigieren. Liegt Ihre Brillenstärke innerhalb dieser Bereiche, kann die IPCL V2.0 Ihr Sehen in der Ferne ohne Brille oder Kontaktlinsen verbessern.
Die Implantation einer IPCL V2.0 erfordert einen chirurgischen Eingriff am Auge, der potenzielle Risiken mit sich bringt. Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig durch und sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die möglichen Risiken.

■ **Einige dieser Risiken sind nachfolgend aufgeführt.**

- Zusätzliche Operation

In manchen Fällen kann ein zweiter chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um die IPCL V2.0 zu entfernen, auszutauschen oder anzupassen. Sie muss möglicherweise während einer Kataraktoperation entfernt werden. Eine zusätzliche Operation kann auch erforderlich sein, um den Augeninnendruck zu senken.

- Kataraktbildung

Nach einer Operation mit einer phaken Intraokularlinse besteht ein erhöhtes Risiko, dass die natürliche Linse Ihres Auges eintrübt und sich ein Katarakt entwickelt, der operativ behandelt werden muss. Je länger die IPCL V2.0 im Auge verbleibt, desto höher wird dieses Risiko. Regelmäßige Augenuntersuchungen sind wichtig, um die Entwicklung eines Kataraktes zu überwachen. Ältere Patienten sowie Patienten mit stärkerer Kurz- oder Weitsichtigkeit können ein höheres Risiko aufweisen. Das Langzeitrisiko über einen Zeitraum von mehr als 7 Jahren hinaus ist nicht bekannt. Falls eine Kataraktoperation erforderlich wird, werden die IPCL V2.0 und die eingetrübte Linse entfernt und wie bei einer routinemäßigen Kataraktoperation eine neue Linse implantiert.

- Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA)

Die häufigste Ursache war die Eintrübung der natürlichen Linse (Katarakt). Nach einer Kataraktoperation kann sich das Sehvermögen dieser Augen verbessern.

- Erhöhter Augeninnendruck und Schädigung des Sehnerves durch erhöhten Augeninnendruck (Glaukom)

Der normale Augeninnendruck (intraokularer Druck oder IOD) kann variieren, liegt jedoch üblicherweise zwischen 10 und 21 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg). Ein höherer als normaler Augeninnendruck wird als okuläre Hypertonie bezeichnet und kann unbehandelt zu einer Schädigung des Sehnervs (Glaukom) und zu dauerhaftem Sehverlust führen.

■ **Verlust von Endothelzellen**
Die Hornhaut (der klare vordere Teil Ihres Auges) besitzt eine dünne Schicht spezieller Zellen, die als Endothelzellen bezeichnet werden. Diese Zellen halten die Hornhaut klar, indem sie überschüssige Flüssigkeit entfernen. Normalerweise nimmt die Anzahl dieser Zellen mit zunehmendem Alter langsam ab. Augenoperationen, einschließlich der Implantation einer IPCL V2.0, können einen zusätzlichen Verlust dieser Zellen verursachen. Wenn zu viele Zellen verloren gehen, kann die Hornhaut trüb werden und Ihr Sehvermögen beeinträchtigen.
Vor der Operation wird Ihr Arzt Ihre Augen untersuchen, um festzustellen, ob Sie für die IPCL V2.0 geeignet sind. Nach der Operation kann im Laufe der Zeit weiterhin ein gewisser Verlust dieser Zellen auftreten. Gehen zu viele Zellen verloren, kann sich Flüssigkeit in der Hornhaut ansammeln (Hornhautödem), was möglicherweise eine Hornhauttransplantation erforderlich macht.

■ **Weitere Komplikationen**
Weitere Risiken im Zusammenhang mit einer IPCL V2.0-Operation können sein:

- Verlagerung des farbigen Teils des Auges (Iris) durch eine Operationswunde in eine Position außerhalb des Auges (Irisprolaps),
- Blutung im Bereich der Netzhaut, der für das Lesevermögen verantwortlich ist (Makulablutung),
- Blutung unter der Netzhaut (subretinale Blutung),
- Zunahme des Brechungsfehlers (Astigmatismus),
- Ablösung oder Zug der Netzhaut aus ihrer natürlichen Position (Netzhautablösung),
- Ungleich große Pupillen (Anisokorie).

Nebenwirkungen und Komplikationen infolge oder nach einer Operation sowie der Implantation einer implantierbaren phaken Kontaktlinse können unter anderem Folgendes umfassen:

- Zunahme des Astigmatismus
- Refraktionsfehler
- Intraokulare Infektion
- Verlust von Glaskörpergewebe
- Vaulting-Problem
- Anteriore subkapsuläre Katarakt
- Schwere intraokulare Entzündung
- Glaukom
- Sekundäres Glaukom
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphäma
- Hypopyon
- Unterkorrektur/Überkorrektur
- Nicht reagierende Pupille
- Endophthalmitis
- TASS (Toxic Anterior Segment Syndrome)
- Netzhautablösung
- Iritis
- Zystoides Makulaödem
- Makulaödem
- Hornhautdekompensation
- Hornhautödem
- Pupillenblock
- Iris-Capture

IT

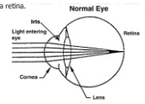
FOGLIO INFORMATIVO PER IL PAZIENTE

Tipo di Dispositivo: Lente Intraoculare (Facica)

Introduzione
Questo foglio informativo per il paziente è stato progettato per aiutarla a decidere se desidera l'impianto di una Lente a Contatto Facica Impiantabile (IPCL V2.0) in uno o entrambi gli occhi per correggere la miopia o l'ipermetropia. È importante comprendere i benefici e i possibili rischi prima di prendere una decisione. La invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discutere eventuali domande con un medico specializzato nella chirurgia IPCL V2.0.

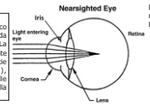
Che cosa sono la miopia e l'ipermetropia?

OCCHIO NORMALE
La luce si focalizza sulla retina.
La visione è nitida.



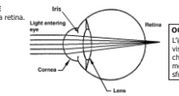
OCCHIO NORMALE:
Il vostro occhio funziona come una macchina fotografica. Vedete gli oggetti perché l'occhio mette a fuoco la luce formando immagini. Sia lo strato anteriore trasparente dell'occhio, chiamato cornea, sia il cristallino naturale focalizzano i raggi luminosi sulla superficie posteriore dell'occhio, chiamata retina.

OCCHIO MIOPE:
La miopia è un difetto di messa a fuoco che provoca una visione più sfocata da lontano rispetto a quella da vicino. La luce proveniente da un oggetto distante viene focalizzata davanti alla superficie posteriore dell'occhio (retina), responsabile della formazione delle immagini, anziché direttamente sulla retina.



OCCHIO MIOPE
La luce si focalizza davanti alla retina.
La visione è sfocata.

OCCHIO IPERMETROPE
La luce si focalizza dietro la retina.
La visione è sfocata.

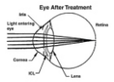


OCCHIO IPERMETROPE:
L'ipermetropia è un comune difetto visivo in cui è possibile vedere chiaramente gli oggetti lontani, mentre quelli vicini possono apparire sfocati.

Gli occhiali e le lenti a contatto possono aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina. Anche la IPCL V2.0 può aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina.

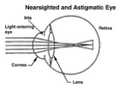
Come corregge la IPCL V2.0 la miopia e l'ipermetropia?

CORREZIONE DELLA VISIONE DOPO L'INTERVENTO CON IPCL V2.0



La diottria (D) è un'unità di misura utilizzata per valutare la capacità dell'occhio di mettere a fuoco. Indica il grado di miopia, ipermetropia o astigmatismo presente. L'intervento con IPCL V2.0 può correggere la miopia da -0,5 D a -15,0 D e l'ipermetropia da +0,5 D a +15,0 D. Se il vostro difetto visivo rientra in questi intervalli, questo intervento può aiutarvi a vedere chiaramente senza occhiali o lenti a contatto.
La lente monofocale IPCL V2.0 non corregge l'astigmatismo. L'astigmatismo è un comune difetto visivo che provoca una visione sfocata o irregolare. Si verifica quando la superficie anteriore dell'occhio (cornea) non ha una forma uniforme. Per questo motivo, la luce non viene focalizzata correttamente all'interno dell'occhio e alcune parti di ciò che vedete possono apparire più nitide di altre.

OCCHIO MIOPE E ASTIGMATICO



La IPCL V2.0 Torica / IPCL V2.0 Presbiopica Torica può correggere l'astigmatismo da +1,0 D fino a +10 D. Vi invitiamo a consultare il vostro medico per scegliere l'opzione più appropriata e adatta ai vostri occhi.

Scelta della lente migliore per la vostra vista
Sono disponibili diversi tipi di lenti. Il vostro oculista vi aiuterà a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Altre opzioni di trattamento includono occhiali con lenti spesse o lenti a contatto in alternativa a un impianto permanente. Parlate con il vostro oculista dei benefici e dei possibili rischi di ciascuna opzione.

Altri trattamenti per correggere miopia e ipermetropia?
Altri trattamenti per correggere la miopia e l'ipermetropia includono occhiali, lenti a contatto e procedure chirurgiche refrattive. Le opzioni chirurgiche comprendono la Cheratectomia Fotorefrattiva (PRK), la Cheratomileusi Laser Assistita In Situ (LASIK), la Sostituzione Refrattiva del Cristallino (RLE) e l'impianto di una lente intraoculare facica (ad esempio IPCL V2.0). Tuttavia, queste procedure potrebbero non soddisfare i requisiti visivi richiesti per alcune professioni, come il servizio militare.

Queste procedure modificano la forma della cornea oppure prevedono l'inserimento di una lente all'interno dell'occhio. La PRK e la LASIK utilizzano un laser per modificare la forma della cornea in modo che l'occhio possa mettere a fuoco meglio. Nella LASIK, un sottile lembo corneale viene sollevato, il laser rimodella il tessuto sottostante e il lembo viene poi ripositionato affinché possa guarire. L'impianto di una lente intraoculare facica, come la IPCL V2.0, aggiunge una lente artificiale all'interno dell'occhio senza rimuovere il cristallino naturale.

Benefici e rischi della IPCL V2.0
L'intervento con IPCL V2.0 può correggere in modo sicuro la miopia compresa tra –0,5 D e –15 D e l'ipermetropia compresa tra +0,5 D e +15 D. Se vostra prescrizione per occhiali rientra in questi intervalli, la IPCL V2.0 può migliorare la vostra visione da lontano senza la necessità di occhiali o lenti a contatto.
L'impianto della IPCL

BACK

- Implantation of an IPCL V2.0 may result in a decrease in corneal endothelial Cell density

Contraindications and Warnings

- Implantable Phakic Contact Lens (IPCL V2.0) is contraindicated in the presence of any of the following circumstances and/or conditions but not limited to the following: Patients with a history of/or clinical signs of iritis, uveitis, synechiae, pigment dispersion syndrome, retinal disease (other than manifestation of myopic degeneration), chronic intraocular inflammation, macular degeneration, irregular astigmatism, keratoconus or cystoid macular edema in either eye
- Patients with diabetic retinopathy in either eye
- Patients with glaucoma in either eye
- Patients with history of previous intraocular surgery (including refractive surgery) in the eye to be treated
- Patients who are amblyopic or blind in the fellow eye
- Patients who do not fall in the range of pretreatment myopia and/or astigmatism as outlined in this clinical protocol inclusion criteria
- Patients with a progressive sight-threatening disease. Patients with retinal findings associated with pathological myopia are allowed
- Patients with a diagnosis of ocular hypertension
- Patients with insulin-dependent diabetes
- Patients with Fuch's dystrophy or other corneal pathology
- Patients with cataract in either eye
- Patients with an unstable refraction in the past 12 months (myopia and/or astigmatism)
- Patients who are pregnant or nursing
- Patients with low/abnormal corneal endothelial cell density
- Patients with Anterior chamber depth <2.8mm

Are You A Good Candidate For IPCL V2.0 Surgery?

Your doctor will perform a detailed eye check-up to see if IPCL V2.0 surgery is suitable for you. You may be considered for this surgery if you:

- are 21 to 45 years old (for Monofocal and Toric lenses) or 40 to 60 years old (for presbyopic lenses)
- have nearsightedness between –0.5 D to –15 D or farsightedness between +0.5 D to +15 D (for IPCL V2.0 Monofocal and IPCL V2.0 Toric) and astigmatism between +1.0 D and +10 D (for IPCL V2.0 Presbyopic and IPCL V2.0 Presbyopic Toric)
- have astigmatism (for toric lenses), if applicable
- have enough space inside your eye to safely place the lens
- have a minimally acceptable density of the thin, single layer of cells (endothelial cells) on the innermost surface of the cornea, responsible for keeping the cornea clear. If your doctor determines that your endothelial cell density is below the minimum level, you will be at greater risk of swelling of your cornea (corneal edema), possibly requiring removal and replacement of your cornea (corneal transplantation)
- have written evidence that your nearsightedness or farsightedness has been stable for at least 1 year
- understand the benefits and risks of the surgery and compared to other treatment options
- have no known allergies to any of the medications that your doctor may discuss will be used before, during and after your surgery
- are not pregnant or breastfeeding
- understand that at between 2 to 3 weeks before IPCL V2.0 surgery you will need to have holes made in the extreme outer edge of the colored portion of the eye (peripheral iridotomy) using a laser
- are willing to sign a consent form before the procedure

You and your doctor will determine if you are a suitable candidate for the IPCL V2.0 (monofocal, toric, presbyopic and presbyopic toric) and the frequency of follow-up required to monitor the health of your eye.

What Should You Expect During IPCL V2.0 Surgery?

Before the Surgery

Before surgery, your doctor will review your medical and eye history and examine both eyes to make sure they are healthy and suitable for IPCL V2.0. This includes checking your eye pressure, measuring the inner layer of your cornea (endothelium). If you wear contact lenses, stop using them 2 to 4 weeks before your eye check-up and surgery. This helps your doctor get accurate measurements. Not doing this may affect your results.

Tell your doctor about any medicines you take, eye problems, past eye surgeries, medical conditions, or allergies. Ask if you should eat or drink before surgery. Also, arrange for someone to take you home, as you should not drive right after the procedure. Your doctor will tell you when it is safe to drive again.

Two to Three Weeks before Surgery

Two to three weeks before your IPCL V2.0 surgery, your doctor will make two holes in the extreme outer edge of the colored portion of the eye (peripheral iridotomies) to prepare your eye for implantation of the IPCL V2.0. This procedure usually takes about 20 to 30 minutes. The holes allow the fluid flows properly from the back chamber to the front chamber of the eye to prevent a buildup of pressure within the eye after IPCL V2.0 surgery. The doctor will usually apply numbing drops to the eye and make tiny openings in the colored portion of the eye (iris) with a laser beam. Usually this doesn't affect your ability to see clearly. The procedure usually takes about 20 to 30 minutes.

After the peripheral iridotomy procedure, you will be prescribed eye drops for you to use. It is important that you follow all medication instructions. Your doctor will instruct you to discontinue the use of these medications before the day of surgery.

The Day of Surgery

On the day of surgery, eye drops will be placed in your eye to enlarge (dilate) the black part of your eye (pupil). Once your pupil is fully dilated, your doctor will put numbing eye drops in your eye and/or inject a needle with numbing medication into your eye and ask you to lie on your back on the treatment table/chair in the treatment room. Your doctor may discuss different options for numbing or relaxing you before the surgery. A small cut is made in the cornea (the clear front part of the eye), and the IPCL V2.0 lens is placed in the correct position inside your eye. The procedure usually takes about 20 to 30 minutes.

After the surgery, your doctor will apply eye drops or ointment and may cover your eye with a patch or shield for protection. The procedure is painless due to the numbing medicine. Do not drive yourself home after surgery. Please arrange for someone to take you home in advance.

The First Day after Surgery

Your doctor will check your eye the day after surgery, including measuring the pressure in your eye. You may feel sensitive to light or feel like something is in your eye. Wearing sunglasses can help. Some discomfort or mild pain is normal, and your doctor may give you medicine to help. If you have severe pain, contact your doctor immediately. You will need to use eye drops or ointment for about a week to prevent infection and reduce inflammation.

IMPORTANT: Use the eye medications as directed by your eye doctor. (Your results may depend upon you following your doctor's instructions).

DO NOT rub your eyes, especially for the first 3 to 5 days after surgery. If you notice any sudden decrease in your vision, you should contact your doctor immediately.

Long Term Care: In some cases, the IPCL V2.0 may need to be replaced or removed. It may be replaced if another lens is better suited for your eye or can give you better vision. It may be removed if you develop a cataract and need cataract surgery In such cases, a new lens can be implanted to help correct your vision.

If the IPCL V2.0 is removed, you will lose the vision correction it provided, and your vision may not be the same as before surgery. It is important to follow your doctor's advice and attend all follow-up visits after surgery.

Questions To Ask Your Doctor

You may want to ask the following questions to help you decide if IPCL V2.0 surgery for nearsightedness or farsightedness is right for you:

- What other options do I have to correct my nearsightedness or farsightedness?
- Will I have to limit my activities after surgery and for how long?
- What are the benefits of IPCL V2.0 surgery for my amount of nearsightedness and farsightedness?
- How will my vision be in the first few months after surgery?
- If IPCL V2.0 surgery does not correct my vision, what is the possibility that my eyeglasses would need to be stronger than before? Could my need for eyeglasses increase over time? Could I undergo a different type of eye surgery for the correction of my vision?
- How is IPCL V2.0 surgery likely to affect my need to wear eyeglasses or contact lenses as I get older?
- Will my eye heal differently if I fund after implantation of the IPCL V2.0?
- Should I have IPCL V2.0 surgery in my other eye?
- How long will I have to wait before I can have surgery in my other eye?
- What vision problems might I experience if I have IPCL V2.0 only in 1 eye?

Summary of Important Information

- IPCL V2.0 Surgery provides a permanent correction of your nearsightedness or farsightedness as long as the IPCL V2.0 remains in the eye. The IPCL V2.0 may be removed. If it is removed, you will lose this benefit, and your vision may not be the same as before surgery.
- IPCL V2.0 surgery does not eliminate the need for reading glasses, even if you have never worn them before.
- Your vision must be stable before IPCL V2.0 surgery. You must provide written evidence that your nearsightedness or farsightedness has changed by no more than 0.50 D each year for at least 1 year.
- If you are pregnant or breastfeeding, you should wait before having this surgery.
- Like all surgeries, IPCL V2.0 has risks. It is important to read and understand all the information before deciding.
- Other options to correct your vision include glasses, contact lenses, and surgeries like RK, PRK, and LASIK.
- Before considering IPCL V2.0 surgery you should:
  a. have a complete eye examination.
  b. talk with at least one eye care professional about IPCL V2.0 surgery, especially the potential benefits, risks, and complications. You should discuss the time needed for healing after surgery.

Magnetic Resonance Compatibility:

The implanted IOL does not contain any metallic components and is safe with no potential for interaction with the Magnetic Resonance (MR) Field. IOL is safer for Magnet Resonance Imaging (MRI) at a magnetic field strength of 1.5 and 3.0 Tesla.

Expected lifetime and necessary follow-up

The IOL will usually last for a patient's lifetime. Should you however encounter any deterioration in your vision quality, please consult your eye doctor for further investigation and treatment. Your eye doctor will discuss with you about the necessary follow-up intervals based on your medical condition.

Reporting of serious incidents

Any serious incident that occurs in relation to the intraocular lens should be reported to your doctor (in the first instance), to the local representative or to the CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED.

About this document:

Your eye doctor has performed the refractive surgery and implanted the intraocular lens (IOL) in your eye. The patient implant card and leaflet have been given to you after the surgery. Please always carry the patient implant card with you to facilitate medical care in case of emergency. The link provided on the implant card will provide you latest updates about the IOL.

Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2020/000163
Manufactured By:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED
Block No.: 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka - Padra,
Dist. Vadodara - 391 440, Gujarat, India.
Toll Free No.: 1800 120 3688
customercare@caregroupiol.com
www.caregroupiol.com

EU REP **European Representative**
OBELIS S.A.
Bd. General Wahis, 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +32.2.732.59.54
Fax:+32.2.732.60.03
Email:mail@obelis.net
Web:www.obelis.net

CE 2460

DE

- Décompensation cornéenne
- Œdème cornéen
- Bloc pupillaire
- Capture de l'Iris
- PIO > 5 mmHg au-dessus de la valeur de référence et PIO > 25 mmHg
- Éblouissements importants et/ou halos autour des lumières
- Décentrement/rotation de l'IPCL V2.0
- Perte de cellules endothéliales cornéennes
- Luxation/rotation de l'IPCL V2.0
- Perte de la meilleure acuité visuelle corrigée par lunettes
- Intervention chirurgicale secondaire pour retirer/remplacer l'IPCL V2.0
- L'implantation d'une IPCL V2.0 peut entraîner une diminution de la densité des cellules endothéliales cornéennes.

Contre-indications et avertissements

- La lentille de contact phake implantable (IPCL V2.0) est contre-indiquée en présence de l'une des circonstances et/ou affections suivantes, sans s'y limiter : patients ayant des antécédents ou des signes cliniques d'iritis, d'uvéite, de synéchies, de syndrome de dispersion pigmentaire, de maladie rétinienne (autre que les manifestations de dégénérescence myopique), d'inflammation intraoculaire chronique, de dégénérescence maculaire, d'astigmatisme irrégulier, de kératocône ou d'œdème maculaire cystoïde dans l'un ou l'autre œil.
- Patients atteints de rétinopathie diabétique dans l'un ou l'autre œil.
- Patients atteints de glaucome dans l'un ou l'autre œil.
- Patients ayant des antécédents de chirurgie intraoculaire antérieure (y compris chirurgie réfractive) dans l'œil à traiter.
- Patients présentant une amblyopie ou une cécité de l'œil controlatéral.
- Patients ne correspondant pas aux plages de myopie et/ou d'astigmatisme avant traitement définies dans les critères d'inclusion de ce protocole clinique.
- Patients atteints d'une maladie évolutive menaçant la vision. Les patients présentant des anomalies rétiniennes associées à une myopie pathologique sont autorisés.
- Patients ayant reçu un diagnostic d'hypertension oculaire.
- Patients atteints de diabète insulinodépendant.
- Patients présentant une dystrophie de Fuchs ou toute autre pathologie cornéenne.
- Patients atteintes de cataracte dans l'un ou l'autre œil.
- Patients dont la réfraction est instable au cours des 12 derniers mois (myopie et/ou astigmatisme).
- Patientes enceintes ou allaitantes.
- Patients présentant une faible densité ou une densité anormale des cellules endothéliales cornéennes.
- Patients présentant une profondeur de chambre antérieure inférieure à 2,8 mm.

Êtes-vous un bon candidat pour la chirurgie IPCL V2.0 ?

Votre médecin réalisera un examen ophtalmologique approfondi afin de déterminer si la chirurgie IPCL V2.0 vous convient. Vous pouvez être considéré comme candidat à cette intervention si vous :

- âtes âgé de 21 à 45 ans (pour les lentilles monofocales et toriques) ou de 40 à 60 ans (pour les lentilles presbyopiques) ;
- présentez une myopie comprise entre –0,5 ht et –15 D ou une hypermétropie comprise entre +0,5 ht et +15 D (pour l'IPCL V2.0 Monofocale et l'IPCL V2.0 Torique), ainsi qu'un astigmatisme compris entre +1,0 D et +10 D (pour l'IPCL V2.0 Presbyopique Torique) ;
- présentez un astigmatisme (pour les lentilles toriques), le cas échéant ;
- disposez d'un espace suffisant à l'intérieur de l'œil pour pouvoir placer la lentille ;
- possédez une densité minimale acceptable de la fine couche unique de cellules (cellules endothéliales) située sur la surface la plus interne de la cornée, responsable du maintien de sa transparence. Si votre médecin détermine que votre densité cellulaire endothéliale est inférieure au niveau minimal requis, vous présenterez un risque accru de gonflement de la cornée (œdème cornéen), pouvant nécessiter l'ablation et le remplacement de votre cornée (transplantation cornéenne) ;
- disposez d'une preuve écrite démontrant que votre myopie ou votre hypermétropie est stable depuis au moins un an ;
- comprenez les avantages et les risques de l'intervention ainsi que leur comparaison avec les autres options thérapeutiques ;
- ne présentez aucune allergie connue aux médicaments que votre médecin prévoit d'utiliser avant, pendant ou après l'intervention ;
- n'êtes pas enceinte et n'allaitez pas ;
- comprenez qu'entre 2 et 3 semaines avant la chirurgie IPCL V2.0, il sera nécessaire de réaliser des ouvertures dans la périphérie extrême de la partie colorée de l'œil (iridotomie périphérique) à l'aide d'un laser ;
- acceptez de signer un formulaire de consentement avant l'intervention.

Vous et votre médecin déterminerez si vous êtes un candidat approprié pour l'IPCL V2.0 (monofocale, torique, presbyopique ou presbyopique torique) ainsi la fréquence des consultations de suivi nécessaires pour surveiller la santé de votre œil.

À quoi devez-vous vous attendre pendant la chirurgie IPCL V2.0 ?

Avant l'intervention

Avant l'intervention, votre médecin examinera vos antécédents médicaux et ophtalmologiques et procédera à un examen de vos deux yeux afin de s'assurer qu'ils sont sains et appropriés pour l'IPCL V2.0. Cet examen comprend un contrôle de votre pression oculaire et l'évaluation de la couche interne de votre cornée (endothélium).Si vous portez des lentilles de contact, vous devez arrêter de les utiliser 2 à 4 semaines avant votre examen ophtalmologique et votre intervention. Cela permet à votre médecin d'obtenir des mesures exactes. Le non-respect de cette consigne peut affecter votre résultat.

Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, de tout problème oculaire, de toute intervention chirurgicale oculaire antérieure, de vos antécédents médicaux ou de vos allergies. Demandez à votre médecin si vous pouvez manger ou boire avant votre intervention. Organisez également qu'une autre personne vous conduise chez votre médecin, car vous ne devez pas conduire immédiatement après l'intervention. Votre médecin vous indiquera à quel moment vous pourrez reprendre la conduite en toute sécurité.

Deux à trois semaines avant l'intervention

Deux à trois semaines avant votre chirurgie IPCL V2.0, votre médecin réalisera deux ouvertures dans la périphérie extrême de la partie colorée de l'œil (iridotomies périphériques) afin de préparer votre œil à l'implantation de l'IPCL V2.0. Cette procédure est nécessaire pour assurer une bonne circulation du liquide entre la chambre postérieure et la chambre antérieure de l'œil et ainsi prévenir une augmentation de la pression intraoculaire après la chirurgie IPCL V2.0.
Le médecin appliquera généralement des gouttes anesthésiantes dans l'œil puis crée de petites ouvertures dans la partie colorée de l'œil (iris) à l'aide d'un faisceau laser. Cette procédure n'affecte généralement pas votre capacité à rentrer chez vous en toute sécurité, mais il est recommandé de vérifier ce point avec votre médecin.
Après l'iridotomie périphérique, des collyres vous seront prescrits. Il est important de suivre toutes les instructions relatives aux médicaments. Votre médecin vous indiquera quand arrêter leur utilisation avant le jour de l'intervention.

Le jour de l'intervention

Le jour de l'intervention, des gouttes ophtalmiques seront instillées dans votre œil afin de dilater la partie noire de l'œil (la pupille). Une fois la pupille complètement dilatée, votre médecin appliquera des gouttes anesthésiantes et/ou réalisera une injection anesthésique dans votre œil, puis vous demandera de vous allonger sur le dos sur la table ou le fauteuil de traitement.
Votre médecin pourra discuter avec vous des différentes options de l'anesthésie ou de relaxation avant l'intervention. Une petite incision est pratiquée dans la cornée (la partie transparente située à l'avant de l'œil), puis la lentille IPCL V2.0 est placée dans la position appropriée à l'intérieur de l'œil. L'intervention dure généralement entre 20 et 30 minutes.

Après l'intervention, votre médecin appliquera des collyres ou une pommade ophtalmique et pourra recouvrir votre œil d'un pansement ou d'une coque de protection. Grâce à l'anesthésie, l'intervention est indolore. Ne conduisez pas pour rentrer chez vous après l'opération. Veuillez prévoir à l'avance qu'une autre personne vous accompagne.

Le premier jour après l'intervention

Votre médecin examinera votre œil le lendemain de l'intervention, notamment en mesurant la pression intraoculaire. Vous pourrez ressentir une sensibilité à la lumière ou avoir l'impression qu'un corps étranger se trouve dans votre œil. Le port de lunettes de soleil peut être utile. Une certaine gêne ou une douleur légère est normale, et votre médecin pourra vous prescrire un traitement pour vous soulager. Si vous ressentez une douleur importante, contactez immédiatement votre médecin.
Vous devrez utiliser des collyres ou une pommade ophtalmique pendant environ une semaine afin de prévenir les infections et de réduire l'inflammation.

IMPORTANT : Utilisez les médicaments ophtalmiques conformément aux instructions de votre ophtalmologiste. (Vos résultats peuvent dépendre du respect des instructions de votre médecin.)

NE vous frottez PAS les yeux, en particulier pendant les 3 à 5 premiers jours suivant l'intervention. Si vous constatez une diminution soudaine de votre vision, vous devez contacter immédiatement votre médecin.

Suivi à long terme : Dans certains cas, l'IPCL V2.0 peut devoir être remplacée ou retirée. Elle peut être remplacée si une autre lentille est mieux adaptée à votre œil ou peut vous offrir une meilleure vision. Elle peut être retirée si vous développez une cataracte nécessitant une chirurgie de la cataracte. Dans ce cas, une nouvelle lentille peut être implantée afin de contribuer à corriger votre vision.

Si l'IPCL V2.0 est retirée, vous perdrez la correction visuelle qu'elle procurait et votre vision pourrait ne plus être identique à celle obtenue après l'intervention. Il est important de suivre les recommandations de votre médecin et d'assister à toutes les visites de suivi après l'intervention.

Questions à poser à votre médecin

Vous pouvez souhaiter poser les questions suivantes afin de vous aider à déterminer si la chirurgie IPCL V2.0 pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie vous convient :

- Quelles autres options ai-je pour corriger ma myopie ou mon hypermétropie ?
- Devrai-je limiter mes activités après l'intervention et pendant combien de temps ?
- Quels sont les avantages de la chirurgie IPCL V2.0 pour mon degré de myopie ou d'hypermétropie ?
- Comment sera ma vision au cours des premiers mois suivant l'intervention ?
- Si la chirurgie IPCL V2.0 ne corrige pas ma vision de manière satisfaisante, est-il possible que mes lunettes nécessitent une correction plus forte qu'auparavant ? Mon besoin de porter des lunettes pourrait-il augmenter avec le temps ? Pourrais-je bénéficier d'un autre type de chirurgie oculaire pour corriger ma vision ?
- Comment la chirurgie IPCL V2.0 est-elle susceptible d'influencer mon besoin de porter des lunettes ou des lentilles de contact en vieillissant ?
- Mon œil cicatrisera-t-il différemment en cas de blessure après l'implantation de l'IPCL V2.0 ?
- Devrais-je subir une chirurgie IPCL V2.0 dans mon autre œil ?
- Combien de temps devrai-je attendre avant de pouvoir faire opérer mon autre œil ?
- Quels problèmes visuels pourrais-je rencontrer si je ne reçois une IPCL V2.0 que dans un seul œil ?

Résumé des informations importantes

- La chirurgie IPCL V2.0 procure une correction permanente de votre myopie ou de votre hypermétropie tant que l'IPCL V2.0 demeure dans l'œil. L'IPCL V2.0 peut toutefois être retirée. Si elle est retirée, vous perdrez ce bénéfice et votre vision pourrait ne plus être identique à celle obtenue après l'intervention.
- La chirurgie IPCL V2.0 n'élimine pas le besoin de porter des lunettes de lecture, même si vous n'en avez jamais porté auparavant.
- Votre vision doit être stable avant la chirurgie IPCL V2.0. Vous devez fournir une preuve écrite démontrant que votre myopie ou votre hypermétropie n'a pas varié de plus de 0,50 D par an pendant au moins un an.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous devez attendre avant de subir cette intervention.
- Comme toute intervention chirurgicale, l'IPCL V2.0 comporte des risques. Il est important de lire et de comprendre toutes les informations avant de prendre votre décision.
- Les autres options pour corriger votre vision comprennent les lunettes, les lentilles de contact et des interventions chirurgicales telles que la RK, la PRK et le LASIK.
- Avant d'envisager une chirurgie IPCL V2.0, vous devez :
  a. subir un examen ophtalmologique complet.
  b. consulter au moins un professionnel de la santé visuelle au sujet de la chirurgie IPCL V2.0, en particulier concernant les bénéfices potentiels, les risques et les complications. Vous devez également discuter du temps de récupération nécessaire après l'intervention chirurgicale.

Compatibilité avec la résonance magnétique

La LIO implantée ne contient aucun composant métallique et ne présente aucun risque d'interaction avec le champ de résonance magnétique (RM). La LIO est compatible avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à des intensités de champ magnétique de 1,5 et 3,0 Tesla.

Durée de vie attendue et suivi nécessaire

La LIO est généralement conçue pour durer toute la vie du patient. Toutefois, si vous constatez une détérioration de la qualité de votre vision, veuillez consulter votre ophtalmologiste afin de procéder à des examens complémentaires et à un traitement approprié. Votre ophtalmologiste discutera avec vous de la fréquence des consultations de suivi nécessaires en fonction de votre état de santé.

Déclaration des incidents graves

Tout incident grave survenu en lien avec la lentille intraoculaire doit être signalé à votre médecin (en premier lieu), au représentant local ou à CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED.

À propos de ce document :

Votre ophtalmologiste a réalisé la chirurgie réfractive et a implanté la lentille intraoculaire (LIO) dans votre œil. La carte d'implant du patient ainsi que cette notice vous ont été remises après l'intervention. Veuillez toujours conserver la carte d'implant du patient sur vous afin de faciliter la prise en charge médicale en cas d'urgence. Le lien indiqué sur la carte d'implant vous permettra d'accéder aux dernières mises à jour concernant la LIO.

N° de licence de fabrication : MFG/MD/2020/000163
Fabriqué par :
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED
Block No. : 310/CEE, Village Dabhasa, Taluka - Padra,
District Vadodara - 391 440, Gujarat, Inde
Numéro vert : 1800 120 3688
Email : customercare@caregroupiol.com
Site web : www.caregroupiol.com

EU REP **Représentant européen**
OBELIS S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32.2.732.59.54
Fax : +32.2.732.60.03
Email : mail@obelis.net
Site web : www.obelis.net

CE 2460

IT

- Augeninnendruck > 5 mmHg über dem Ausgangswert und Augeninnendruck > 25 mmHg
- Erhebliche Blendungen und/oder Halos um Lichtquellen
- Dezentrierung/Drehung der IPCL V2.0
- Verlust von Hornhaut-Endothelzellen
- Linsendislokation/Drehung der IPCL V2.0
- Verlust der bestkorrigierten Sehschärfe mit Brille
- Sekundärer chirurgischer Eingriff zur Entfernung/zum Austausch der IPCL V2.0
- Die Implantation einer IPCL V2.0 kann zu einer Verringerung der Dichte der Hornhaut-Endothelzellen führen.

Kontraindikationen und Warnhinweise

- Die implantierbare phake Kontaktlinse (IPCL V2.0) ist bei Vorliegen einer der folgenden Umstände und/oder Erkrankungen kontraindiziert, ausschließlich, aber nicht beschränkt auf: Patienten mit einer Vorgeschichte von oder klinischen Anzeichen für Iritis, Uveitis, Synechien, Pigmentdispersionssyndrom, Netzhauterkrankungen (außer Manifestationen einer myopischen Degeneration), chronischer intraokularer Entzündung, Makuladegeneration, irregulärem Astigmatismus, Keratokonus oder zystoidem Makulaödem in einem der Augen.
- Patienten mit diabetischer Retinopathie in einem der Augen.
- Patienten mit Glaukom in einem der Augen.
- Patienten mit vorausgegangenen intraokularen Operationen (einschließlich refraktiver Chirurgie) am zu behandelnden Auge.
- Patienten mit Amblyopie oder Blindheit des Partnerauges.
- Patienten, deren Myopie und/oder Astigmatismus nicht innerhalb der in diesem klinischen Protokoll festgelegten Einschlusskriterien liegt.
- Patienten mit einer fortschreitenden, das Sehvermögen bedrohenden Erkrankung. Patienten mit Netzhautbefunden im Zusammenhang mit pathologischer Myopie sind zulässig.
- Patienten mit diagnostizierter okulärer Hypertonie.
- Patienten mit insulinabhängigem Diabetes.
- Patienten mit Fuchsscher Hornhautdystrophie oder anderen Hornhauterkrankungen.
- Patienten mit Katarakt in einem der Augen.
- Patienten mit instabiler Refraktion in den letzten 12 Monaten (Myopie und/oder Astigmatismus).
- Patientinnen, die schwanger sind oder stillen.
- Patienten mit niedriger oder abnormaler Dichte der Hornhaut-Endothelzellen.
- Patienten mit einer Vorderkammertiefe von < 2,8 mm.

Sind Sie ein geeigneter Kandidat für eine IPCL V2.0-Operation?

Der Arzt wird eine ausführliche Augenuntersuchung durchführen, um festzustellen, ob eine IPCL V2.0-Operation für Sie geeignet ist. Sie kommen möglicherweise für diesen Eingriff infrage, wenn Sie:

- zwischen 21 und 45 Jahre alt sind (für monofokale und torische Linsen) oder zwischen 40 und 60 Jahre alt sind (für presbyopische Linsen),
- eine Kurzsichtigkeit zwischen –0,5 D und –15 D oder eine Weitsichtigkeit zwischen +0,5 D und +15 D aufweisen (für IPCL V2.0 Monofocal und IPCL V2.0 Toric) sowie einen Astigmatismus zwischen +1,0 D und +10 D (für IPCL V2.0 Presbyopic und IPCL V2.0 Presbyopic Toric),
- gegebenenfalls an Astigmatismus leiden (für torische Linsen),
- ausreichend Platz im Auge haben, um die Linse sicher einsetzen zu können,
- eine minderstens akzeptable Dichte der dünnen, einschichtigen Zellschicht (Endothelzellen) auf der innersten Oberfläche der Hornhaut besitzen, die für die Aufrechterhaltung der Hornhautklarheit verantwortlich ist. Wenn Ihr Arzt feststellt, dass Ihre Endothelzelldichte unter dem Mindestwert liegt, besteht ein erhöhtes Risiko für eine Hornhautschwellung (Hornhautödem), die möglicherweise die Entfernung und Ersatz der Hornhaut (Hornhauttransplantation) erforderlich macht,
- schriftlich nachweisen können, dass Ihre Kurz- oder Weitsichtigkeit seit mindestens einem Jahr stabil ist,
- die Vorteile und Risiken der Operation sowie ihre Vergleichbarkeit mit anderen Behandlungsmöglichkeiten verstehen,
- keine bekannten Allergien gegen Medikamente haben, die Ihr Arzt vor, während oder nach der Operation anwenden könnte,
- nicht schwanger sind und nicht stillen,
- verstehen, dass etwa 2 bis 3 Wochen vor der IPCL V2.0-Operation mittels Laser kleine Öffnungen am äußersten Rand des farbigen Teils des Auges (peripheren Iridotomie) angelegt werden müssen, bereit sind, vor dem Eingriff eine Einverständniserklärung zu unterzeichnen.

Sie und Ihr Arzt werden gemeinsam entscheiden, ob Sie ein geeigneter Kandidat für die IPCL V2.0 (monofokal, torisch, presbyopisch und presbyopisch torisch) sind und in welchen Abständen Nachsorgeuntersuchungen erforderlich sind, um die Gesundheit Ihres Auges zu überwachen.

Was können Sie während einer IPCL V2.0-Operation erwarten?

Vor der Operation

Vor der Operation wird Ihr Arzt Ihre medizinische und augenärztliche Vorgeschichte prüfen und beide Augen untersuchen, um sicherzustellen, dass sie gesund und für die IPCL V2.0 geeignet sind. Dazu gehört auch die Untersuchung Ihrer Augeninnendruck und der inneren Schicht Ihrer Hornhaut (Endothel). Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, sollten Sie deren Verwendung 2 bis 4 Wochen vor Ihrer Augenuntersuchung und der Operation einstellen. Dies hilft Ihrem Arzt, genaue Messwerte zu erhalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Ihr Ergebnis beeinflussen.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen, über Augenprobleme, frühere Augenoperationen, bestehende Erkrankungen oder Allergien. Fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie vor der Operation essen oder trinken dürfen. Organisieren Sie außerdem eine Begleitperson für die Heimfahrt, da Sie unmittelbar nach dem Eingriff nicht selbst fahren sollten. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wann Sie wieder sicher ein Fahrzeug führen dürfen.

Zwei bis drei Wochen vor der Operation

Zwei bis drei Wochen vor Ihrer IPCL V2.0-Operation wird Ihr Arzt zwei kleine Öffnungen am äußersten Rand des farbigen Teils Ihres Auges (peripheren Iridotomien) anlegen, um Ihr Auge auf die Implantation der IPCL V2.0 vorzubereiten. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Augenflüssigkeit ordnungsgemäß von der hinteren Augenkammer in die vordere Augenkammer fließen kann und um einen Druckanstieg in Ihrem Auge nach der IPCL V2.0-Operation zu verhindern.
Der Arzt wird in der Regel betäubende Augentropfen anwenden und mithilfe eines Laserstrahls kleine Öffnungen in der Iris erzeugen. Normalerweise beeinträchtigt dieser Eingriff nicht Ihre Fähigkeit, anschließend selbst nach Hause zu fahren. Bitte klären Sie dies jedoch mit Ihrem Arzt.
Nach der peripheren Iridotomie werden Ihnen Augentropfen verschrieben. Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen zur Anwendung der Medikamente, die Ihnen Ihr Arzt wird Sie darüber informieren, wann Sie die Anwendung dieser Medikamente vor dem Operationstag beenden sollen.

Am Tag der Operation

Am Tag der Operation werden Augentropfen in Ihr Auge gegeben, um den schwarzen Teil Ihres Auges (die Pupille) zu erweitern (zu dilatieren). Sobald Ihre Pupille vollständig erweitert ist, wird Ihr Arzt betäubende Augentropfen verabreichen und/oder ein Betäubungsmittel mittels Injektion in Ihr Auge einbringen und Sie bitten, sich auf dem Behandlungstisch bzw. Behandlungsstuhl im Operationsraum auf den Rücken zu legen.
Vor der Operation kann Ihr Arzt verschiedene Möglichkeiten zur Betäubung oder Beruhigung mit Ihnen besprechen. Anschließend wird ein kleiner Schnitt in die Hornhaut (den klaren vorderen Teil des Auges) gesetzt, und die IPCL V2.0-Linse wird in die korrekte Position im Auge eingesetzt. Der Eingriff dauert in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten.

Nach der Operation wird Ihr Arzt Augentropfen oder eine Augensalbe anwenden und Ihr Auge möglicherweise mit einem Verband oder einer Schutzschale abdecken. Dank der Betäubung ist der Eingriff schmerzfrei. Fahren Sie nach der Operation nicht selbst nach Hause. Bitte organisieren Sie im Voraus eine Person, die Sie nach Hause bringt.

Der erste Tag nach der Operation

Ihr Arzt wird Ihr Auge am Tag nach der Operation untersuchen, einschließlich der Messung des Augeninnendrucks. Möglicherweise sind Sie lichtempfindlich oder haben das Gefühl, dass sich etwas in Ihrem Auge befindet. Das Tragen einer Sonnenbrille kann hilfreich sein. Leichte Beschwerden oder geringe Schmerzen sind normal, und Ihr Arzt kann Ihnen Medikamente zur Linderung verschreiben. Wenn Sie starke Schmerzen haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Sie müssen etwa eine Woche lang Augentropfen oder eine Augensalbe anwenden, um Infektionen vorzubeugen und Entzündungen zu reduzieren.

WICHTIG: Verwenden Sie die Augenmedikamente genau nach Anweisung Ihres Augenarztes. (Der Erfolg der Behandlung kann davon abhängen, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes befolgen.)

Reiben Sie Ihre Augen **NICHT**, insbesondere in den ersten 3 bis 5 Tagen nach der Operation. Wenn Sie eine plötzliche Verschlechterung Ihres Sehvermögens bemerken, sollten Sie unverzüglich Ihren Arzt kontaktieren.

Langfristige Nachsorge:

In einigen Fällen muss die IPCL V2.0 ersetzt oder entfernt werden. Sie kann ersetzt werden, wenn eine andere Linse besser für Ihr Auge geeignet ist oder ein besseres Sehvermögen ermöglicht. Sie kann entfernt werden, wenn sich ein Katarakt entwickelt und eine Kataraktoperation erforderlich wird. In solchen Fällen kann eine neue Linse implantiert werden, um Ihr Sehvermögen zu korrigieren.

Wird die IPCL V2.0 entfernt, verlieren Sie die durch sie erzielte Sehkorrektur, und Ihr Sehvermögen entspricht möglicherweise nicht mehr dem Zustand nach der Operation. Es ist wichtig, die Anweisungen Ihres Arztes zu befolgen und alle Nachsorgetermine nach der Operation wahrzunehmen.

Fragen, die Sie Ihrem Arzt stellen können

Möglicherweise möchten Sie die folgenden Fragen stellen, um zu entscheiden, ob eine IPCL V2.0-Operation zur Korrektur Ihrer kurz- oder Weitsichtigkeit für Sie geeignet ist:

- Welche anderen Möglichkeiten habe ich zur Korrektur meiner Kurz- oder Weitsichtigkeit?
- Muss ich meine Aktivitäten nach der Operation einschränken, und wenn ja, für wie lange?
- Welche Vorteile bietet die IPCL V2.0-Operation bei meinem Grad an Kurz- oder Weitsichtigkeit?
- Wie wird mein Sehvermögen in den ersten Monaten nach der Operation sein?
- Falls die IPCL V2.0-Operation mein Sehvermögen nicht ausreichend korrigiert, wie wahrscheinlich ist es, dass ich stärkere Brillengläser als zuvor benötige? Könnte mein Bedarf an Brillen im Laufe der Zeit zunehmen? Könnte ich mich einer anderen Art von Augenoperation zur Sehkorrektur unterziehen?
- Wie wird sich die IPCL V2.0-Operation voraussichtlich auf meinen Bedarf an Brillen oder Kontaktlinsen im Alter auswirken?
- Wird mein Auge nach einer Verletzung anders heilen, wenn eine IPCL V2.0 implantiert wurde?
- Sollte ich auch an meinem anderen Auge eine IPCL V2.0-Operation durchführen lassen?
- Wie lange muss ich warten, bevor ich mein anderes Auge operieren lassen kann?
- Welche Sehprobleme könnten auftreten, wenn ich die IPCL V2.0 nur in einem Auge implantiert bekomme?

Zusammenfassung wichtiger Informationen

- Die IPCL V2.0-Operation bietet eine dauerhafte Korrektur Ihrer Kurz- oder Weitsichtigkeit, solange die IPCL V2.0 im Auge verbleibt. Die IPCL V2.0 kann entfernt werden. Wird sie entfernt, geht dieser Vorteil verloren, und Ihr Sehvermögen entspricht möglicherweise nicht mehr dem Zustand vor der Operation.
- Die IPCL V2